



Collection MedWIZ

4^e année médecine

MALADIES INFECTIEUSES

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Méningites purulentes bactériennes	8				
02	Méningite à liquide clair	12				
03	Sepsis – Choc septique	14				
04	Infections staphylococciques	16				
05	Choléra	20				
06	Sepsis à gram négatif (SBGN) et choc septique	22				
07	Infections nosocomiales	24				
08	Brucellose (Fièvre de Malte)	28				
09	Leptospiroses	30				
10	Fièvre boutonneuse méditerranéenne (FBM)	32				
11	Dermohypodermes bactériennes nécrosantes et non nécrosantes	34				
12	Exanthème fébrile	38				
13	Fièvre typhoïde	42				
14	Diphtérie	44				
15	Amoébose	46				
16	Rage	50				
17	Tétanos	52				
18	Toxoplasmose	54				
19	Infections à streptocoque	56				
20	Rubéole	60				
21	Paludisme	62				
22	Infections à herpès virus	66				
23	Infection à VIH	70				
24	Antibiotiques	72				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
25	Règles de prescription des antibiotiques	76				
26	Fièvre aiguë récente	78				
27	Diarrhées infectieuses	80				
28	Ictère fébrile	82				
29	Risque rabique	84				
30	Accident d'exposition au sang et aux liquides biologiques (AES)	86				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

MÉNINGITES PURULENTES BACTÉRIENNES (1)

I. DÉFINITION

- Infection grave du système nerveux central, urgence diagnostique et thérapeutique. Mortalité élevée et séquelles neurologiques sans traitement précoce.

II. PRINCIPALES ÉTIOLOGIES PAR ÂGE

Population	Germes
Adulte + enfant ≥ 5 ans	Méningocoque, Pneumocoque, Listeria
Nourrisson + enfant < 5 ans	Méningocoque, Pneumocoque, Haemophilus
Nouveau-né	Streptocoque B, E. coli, Listeria

III. ORIENTATION ÉTIOLOGIQUE

- Pneumocoque : traumatisme crânien, brèche, immunodépression, début brutal, signes neuro focaux
- Méningocoque : saison froide, épidémie, purpura, terrain déficit complément
- Haemophilus : < 5 ans, non vacciné, conjonctivite + otite
- Listeria : > 50 ans, immunodépression, grossesse, rhombencéphalite

IV. DIAGNOSTIC CLINIQUE

Syndrome méningé fébrile :

- Céphalées violentes, vomissements en jet, photophobie
- Raideur de nuque, signe de Kernig (+), signe de Brudzinski (+)
- Fièvre, altération état général

Signes de gravité :

- Purpura extensif, coma, signes de localisation, convulsions, instabilité HD/RESP, engagement cérébral

V. PONCTION LOMBAIRE

A. CONTRE-INDICATIONS

1. CI neurologiques (scanner avant PL) :

- Signes de localisation, convulsions focales, troubles vigilance avec anomalies pupillaires

2. CI non neurologiques :

- Infection cutanée, instabilité HD/RESP, troubles hémostasie, anticoagulants

B. LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN (LCS)

1. LCS normal :

- < 5 cellules/mm³
- Glycorachie = 66% glycémie
- Protéines 0,3-0,4 g/L

2. LCS méningite purulente :

- Aspect trouble/purulent
- Leucocytes $> (PNN)$
- Glycorachie basse ($< 40\%$ glycémie)
- Protéinorachie élevée ($> 0,5$ g/L)
- Lactates élevés ($> 3,8$ mmol/L)

MÉNINGITES PURULENTES BACTÉRIENNES (2)

VI. TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

- URGENCE ABSOLUE

**** Début < 1h après admission,
max 3h ****

- Probabiliste 1^{ère} intention
- C3G : Céfotaxime 200-300 mg/kg/j OU Ceftriaxone 75-100 mg/kg/j
- Si suspicion *Listeria* : ajouter
 - Amoxicilline 200 mg/kg/j
 - + Gentamycine 3-5 mg/kg/j
- Si allergie bêtalactamines :
Vancomycine + Rifampicine
- Selon examen direct

Germe	Traitement
Cocci G+ (pneumocoque)	C3G
Cocci G- (méningocoque)	Amoxicilline
Bacille G- (<i>H. influenzae</i>)	C3G
Bacille G+ (<i>Listeria</i>)	Amoxicilline + Gentamycine
Bacille G- (<i>E. coli</i>)	C3G

- Durées
 - Méningocoque : 4-7 jours
 - Pneumocoque : 10-14 jours
 - *Listeria* : 21 jours (Amox) + 5 jours (Gentamicine)
 - *E. coli* : 21 jours

VII. CORTICOTHÉRAPIE

(Dexaméthasone)

- Indications :
 - Pneumocoque (tout âge)
 - Méningocoque adulte
 - *Haemophilus* enfant
 - LCS trouble
- Posologie :
 - Adulte 10 mg/6h x 4 jours
 - Enfant 0,15 mg/kg/6h x 4 joursÀ administrer avec la 1^{ère} dose d'ATB (possible jusqu'à 12h après)
- Non recommandée : immunodéprimés, listériose

VIII. SURVEILLANCE

- Température, signes neurologiques, conscience
- TDM/IRM cérébrale si nouveaux signes ou fièvre persistante
- Pas de PL de contrôle sauf évolution défavorable
- Suivi 12 mois (audition, séquelles)

IX. PRÉVENTION

- Déclaration obligatoire
- Chimio prophylaxie de l'entourage (méningocoque, *Haemophilus*)
- Vaccination (méningocoque, pneumocoque, *Haemophilus*)
- Traitement des portes d'entrée ORL et brèches